TESTDOKUMENT · Inte publicerat eller granskat av PM:ets författare · Sammanfattningen är gjord av Kjell Stefansson, inte av författarna

LOKALT PM · REGION UPPSALA

AKUT DIVERTIKULIT

Diagnostik • Klassifikation • Uppföljning

01 DIAGNOSTIK

Källa s. 1

- **DT buk med kontrast** är förstahandsmetod.
- DT utan kontrast kan visa okomplicerad divertikulit, men kontrast behövs ofta för att säkert identifiera komplikationer.

02 KLASSIFICERA FYNDEN

Källa s. 1

OKOMPLICERAD

Hinchey 0–Ia

Lokal inflammation utan abscess, gas eller fistel.

KOMPLICERAD

Hinchey Ib–IV

Abscess, perforation, fri gas, fistel eller obstruktion.

03 UPPFÖLJNING – KOLONUTREDNING

Källa s. 1

INGEN RUTINMÄSSIG UTREDNING

Om allt detta gäller och ingen situation i högra kolumnen föreligger:

- Okomplicerad divertikulit
- Verifierad med DT med intravenös kontrast
- Patienten är återställd efter 6 veckor

KOLONUTREDNING EFTER 6–8 VECKOR

Motiverad vid:

- Kliniskt ställd diagnos (utan DT) och kolonutredning saknas eller är >3 år gammal
- Komplicerad divertikulit och kolonutredning saknas eller är >3 år gammal
- Radiologiskt oklara fynd där malignitet inte kan uteslutas
- Recidiv av okomplicerad divertikulit hos patient som inte utretts tidigare

METOD

Koloskopi eller DT-kolon (>75 år).

PATIENTRÅD

Källa s. 1–2

- Instruera patienten att kontakta vården om förbättring uteblir.
- Fiberrik kost, motion, normal vikt, rökstopp och undvik NSAID.

Region Uppsala: ”Akuta divertikuliter - omhändertagande, VO kirurgi och urologi”.
DocPlusSTYR-9633 · version 5 · godkänt 2026-04-15.
Via akutkompassen.se/#pm=9633 · hämtat 2026-10-08.
Original-PM (DocPlus)

OM SAMMANFATTNINGEN

Detta är en sammanfattning av det angivna källdokumentet, genererad av Kjell Stefansson, ST-läkare i akutsjukvård, med hjälp av AI. Sammanfattningen ersätter inte originaldokumentet. Kontrollera aktuell version och lokal tillämplighet.

TESTDOKUMENT
Sammanfattning av Kjell Stefansson, inte av PM:ets författare